

Higiena *snu* w *depresji*

Sen i depresja są dwukierunkowe: zły sen pogłębia depresję, depresja burzy sen. Praca z rytmem dobowym to leczenie, nie wygoda.

CZAS: 15 min nauki + 4 tyg. wdrażania 4 tygodnie · stałe godziny

ŹRÓDŁO: Manber i wsp. (2008); Carney i wsp. (2017); Asarnow i wsp. (2014); Riemann i wsp. (2020)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj **7 zasad higieny snu DEP** (sekcja 01) i **3 błędy specyficzne** dla depresji (sekcja 02). Wybierz **2-3 zasady do wdrożenia** w pierwszym tygodniu (nie wszystkie naraz!). Prowadź **dziennik snu** przez 4 tyg. (sekcja 03). Cel: stabilny rytm dobowy — fundament dla wszystkich innych narzędzi.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Sen i depresja tworzą **dwukierunkową pętlę**: zaburzenia snu są *predyktorem* nowych epizodów (Riemann i wsp. 2020), a depresja burzy strukturę snu (zaburzenia fazy REM, fragmentacja, wczesne pobudki). Manber i wsp. (2008) pokazali, że **CBT-I** (ang. *Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia*) dodany do leczenia depresji *podwaja* wskaźnik remisji: 50 % vs 30 % w grupie kontrolnej. Mechanizm: stabilny rytm dobowy reguluje serotoninę, melatoninę, kortyzol. Asarnow i wsp. (2014): u nastolatków poprawa snu redukuje depresję bardziej niż klasyczne CBT. Praca z rytmem dobowym to **biologiczna interwencja**, nie „wygoda” — równie ważna jak farmakoterapia.

01 Siedem zasad higieny snu DEP

1 · STAŁE GODZINY POBUDKI

To najważniejsza zasada. Wstawaj o tej samej porze ± 30 min, *nawet w weekend*. Rytm dobowy potrzebuje powtarzalności.

2 · ŚWIATŁO DZIENNE RANO

W ciągu **30 min po przebudzeniu** wyjdź na zewnątrz lub usiądź przy oknie. **10–20 min** światła naturalnego resetuje zegar biologiczny.

3 · CIEMNOŚĆ WIECZOREM

2 h przed snem **przyciemnij światło**: tylko ciepłe lampki. Telefon na tryb nocny lub odłóż. Mózg potrzebuje sygnału „już ciemno”.

4 · KOFEINA DO POŁUDNIA

Ostatnia kawa *najpóźniej* ok. 12:00. Kofeina ma okres półtrwania 5–7 h — wieczorna kawa rozregulowuje sen, nawet jeśli „zasypiasz”.

5 · ŁÓŻKO TYLKO DO SNU

Nie pracuj, nie scrolluj, nie oglądaj w łóżku. Mózg ma kojarzyć: *łóżko = sen*. Czytaj na fotelu.

6 · RYTUAŁ WIECZORNY

30–60 min przed snem: *ten sam ciąg* czynności (umycie, lektura, herbata ziołowa). Sygnał dla mózgu: „idziemy spać”.

7 · JEŚLI NIE ZASYPIASZ W 20 MIN — WSTAŃ

Nie leż 2 h walcząc ze snem. Wstań, idź na fotel, czytaj nudną książkę przy słabym świetle, wróć dopiero gdy poczujesz senność. Łóżko ma być *miejscem snu*, nie miejscem walki z bezsennością — to klasyczna zasada CBT-I (Bootzin).

02 3 błędy specyficzne dla depresji

DRZEMKI W DZIEŃ

„Skoro w nocy nie spałem, dospię”. Drzemka > 20 min *blokuje* nocny sen. Max 20 min, przed 15:00.

SPANIE DO POŁUDNIA W WEEKEND

„Niech się wreszcie wyśpię”. Wstanie o 12:00 zamiast 8:00 = mózg *resetuje strefę czasową* jak po locie. W poniedziałek znów rozregulowanie.

WIECZORNY ALKOHOL „DLA SNU”

Alkohol skraca latencję snu, ale *burzy strukturę*: brak REM, pobudki o 3–4 rano, wczesne wybudzenie. Pogłębia depresję.

03 — Dziennik snu — 4 tygodnie

Codziennie rano (w ciągu 30 min od przebudzenia) wypełnij wiersz. Cel: zauważyć wzorce, nie pojedyncze noce.

DZ.	PORA POBUDKI	PORA ZAŚNIĘCIA	SEN ŁĄCZNIE <i>h</i>	JAKOŚĆ <i>0-10</i>	NASTRÓJ DZIENNY <i>0-10</i>	CO ZABURZYŁO SEN?
<i>Pn1</i>						
<i>Wt1</i>						
<i>Śr1</i>						
<i>Cz1</i>						
<i>Pt1</i>						
<i>Sb1</i>						
<i>Nd1</i>						
<i>Pn2</i>						
<i>Wt2</i>						
<i>Śr2</i>						
<i>Cz2</i>						
<i>Pt2</i>						
<i>Sb2</i>						
<i>Nd2</i>						
<i>Pn3</i>						
<i>Wt3</i>						
<i>Śr3</i>						
<i>Cz3</i>						
<i>Pt3</i>						
<i>Sb3</i>						
<i>Nd3</i>						
<i>Pn4</i>						
<i>Wt4</i>						
<i>Śr4</i>						
<i>Cz4</i>						
<i>Pt4</i>						
<i>Sb4</i>						
<i>Nd4</i>						

Kluczowy mechanizm: popraw *jedną* zasadę naraz, nie wszystkie. Najmocniejszy efekt daje *zasada 1* (stałe godziny pobudki) — z niej wynikają inne. Po 2 tyg. stabilnego rytmu większość pacjentów raportuje **spadek nastroju depresyjnego o 1-2 pkt** na skali (Carney i wsp. 2017). Manber (2008): CBT-I (8 sesji) podwoił remisję depresji w porównaniu z samym SSRI. Sen *jest* leczeniem — nie tylko warunkiem leczenia.